



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
POPULASI KHUSUS**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 552.172/I-PDM/DIR/VI/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan Populasi Khusus

Disusun oleh :
Penanggung jawab BAB PP



(Wiwit Indah Yanti, S.Kep.,Ns)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini M.Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Populasi Khusus dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Populasi khusus ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 01 Oktober 2025

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini M.Kes

TIM PENYUSUN

Pengarah & Editor : Dr. dr. Aslichah, M. Kes.,AFP.,CChT.,CI.,CHEA.,CHQP

Penyusun:

1. Puput Sekar Nariratih, AMd. Keb
2. Ns. Wiwit Indah Yanti, S. Kep
3. Ns. Very Susanto, S. Kep
4. Wahyuni, AMd. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
PERATURAN DIREKTUR	v
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.3 SASARAN	9
1.4 RUANG LINGKUP	9
1.5 PENGERTIAN	9
BAB II PELAYANAN TERHADAP POPULASI PASIEN USIA LANJUT	11
BAB III PELAYANAN TERHADAP POPULASI DISABILITAS	12
BAB IV PELAYANAN TERHADAP POPULASI ANAK	13
BAB V PELAYANAN TERHADAP POPULASI YANG BERISIKO DISIKSA	15
BAB VI PELAYANAN TERHADAP POPULASI YANG BERISIKO BUNUH DIRI	16
BAB VII PENUTUP	17

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 552.172/I-PDM/DIR/VI/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN POPULASI KHUSUS

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Prima Husada, untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam hal pelayanan populasi khusus;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 552.172/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman pelayanan populasi khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Populasi Khusus;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Repulbik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG TENTANG PEDOMAN PELAYANAN POPULASI KHUSUS.**

BAB I

PELAYANAN TERHADAP POPULASI PASIEN USIA LANJUT

Pasal 1

- (1) Proses identifikasi pasien usia lanjut.

-
- (2) Staf dilatih untuk pemberian pelayanan pada pasien usia lanjut.
 - (3) Pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien usia lanjut.

BAB II PELAYANAN TERHADAP POPULASI DISABILITAS

Pasal 2

- (1) Proses identifikasi pasien dengan disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana yang ramah pasien disabilitas.
- (3) Pelaksanaan pemerian pelayanan pada pasien disabilitas.

BAB III PELAYANAN TERHADAP POPULASI ANAK

Pasal 3

- (1) Proses identifikasi pasien usia anak.
- (2) Staf dilatih untuk pemberian pelayanan pada pasien anak.
- (3) Pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien anak.

BAB IV PELAYANAN TERHADAP POPULASI YANG BERISIKO DISIKSA

Pasal 4

- (1) Proses identifikasi pasien yang berisiko disiksa.
- (2) Pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien yang berisiko disiksa.

BAB V PELAYANAN TERHADAP POPULASI YANG BERISIKO BUNUH DIRI

Pasal 5

- (1) Proses identifikasi pasien yang berisiko bunuh diri.
- (2) Pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien yang berisiko bunuh diri.

Pasal 6

Aktivitas manajer pelayanan pasien (MPP) dicatat dalam rekam medis

Pasal 7

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pengkajian tambahan untuk populasi pasien tertentu.
- (2) Pengkajian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain untuk:
 - a) Neonatus
 - b) Anak

-
- c) Remaja
 - d) Obstetri/maternitas
 - e) Geriatri
 - f) Sakit terminal/menghadapi kematian
 - g) Pasien dengan rasa sakit kronik atau nyeri (intense)
 - h) Pasien dengan gangguan emosional atau pasien psikiatris
 - i) Pasien kecanduan obat terlarang atau alcohol
 - j) Korban kekerasan atau kesewenangan
 - k) Pasien dengan penyakit menular atau infeksius
 - l) Pasien yang menerima kemoterapi atau terapi radiasi
 - m) Pasien dengan sistem imunologi terganggu

(3) Terhadap populasi pasien tersebut dilaksanakan pengkajian tambahan sesuai regulasi rumah sakit.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 Oktober 2025
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR: 552.172/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
POPULASI KHUSUS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rumah sakit memberi asuhan kepada pasien untuk berbagai kebutuhannya atau kebutuhan pada populasi khusus. Pedoman ini dapat diaplikasikan pada keadaan khusus saat ada populasi seperti pasien usia lanjut, mereka yang disabilitas, populasi anak, serta populasi yang berisiko disiksa dan risiko tinggi lainnya termasuk pasien dengan risiko bunuh diri. Perlu diingatkan pentingnya melibatkan suatu tim multidisiplin, termasuk profesional kesehatan lainnya yang terkait, yang dapat membantu dan mendukung perawatan pasien.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

- A. Maksud
Maksud disusunnya pedoman populasi khusus adalah untuk digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi para Profesional Pemberi Asuhan (PPA), MPP, dan bagian keamanan dalam memberikan pelayanan pada populasi khusus.
- B. Tujuan
Pedoman populasi khusus bertujuan agar Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dan MPP dapat memberikan pelayanan pada pasien berisiko tinggi secara profesional sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaannya sangat memperhatikan keselamatan pasien serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

1.3 SASARAN

- 1. Profesional Pemberi Asuhan (PPA)
- 2. Manajer Pelayanan Pasien (MPP)
- 3. Bagian keamanan Rumah Sakit

1.4 RUANG LINGKUP

- 1. Ruang rawat inap
- 2. Instalasi Gawat Darurat
- 3. Instalasi Rawat Jalan
- 4. Instalasi Kamar Operasi

1.5 PENGERTIAN

- 1. Pelayanan pasien usia lanjut adalah rangkaian pelayanan pada pasien yang berusia diatas 60 tahun keatas dengan satu atau lebih masalah kesehatan (multipatologi) akibat gangguan fungsi jasmani dan rohani dan atau kondisi sosial yang bermasalah (geriatri).

-
2. Pelayanan terhadap pasien yang penyandang disabilitas baik disabilitas sejak lahir maupun disabilitas yang didapatkan karena kecelakaan maupun trauma fisik. Penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai keterbatasan mental, fisik, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu yang lama.
 3. Pemberian asuhan kepada pasien dengan kriteria anak yang membutuhkan bantuan orang lain/ petugas kesehatan karena kebutuhan ketergantungan, seperti:
 - Pasien dengan batasan umur di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun
 - Pasien anak dengan kondisi sakit sedang dan sakit berat.
 - Pasien anak dengan kondisi terpasang alat.
 4. Pelayanan terhadap populasi yang berisiko disiksa seperti korban KDRT, pelaku kejahatan yang dirawat di Rumah Sakit, korban pemerkosaan, korban kekerasan lainnya, maupun populasi yang mendapat tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa
 5. Bunuh diri merupakan salah satu bentuk kegawat daruratan psikiatri. Bunuh diri adalah perilaku yang membutuhkan pengkajian yang komprehensif pada depresi, penyalahgunaan NAPZA, skizofrenia, gangguan kepribadian (paranoid, borderline, antisocial), bunuh diri tidak bisa disamakan dengan penyakit mental

BAB II

PELAYANAN TERHADAP POPULASI PASIEN USIA LANJUT

2.1. PENGERTIAN

Pelayanan terhadap Populasi Pasien Usia Lanjut adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan secara komprehensif, berkesinambungan, aman, dan bermutu kepada pasien berusia 60 tahun ke atas, dengan memperhatikan perubahan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang khas pada usia lanjut, guna mempertahankan, meningkatkan, atau memulihkan derajat kesehatan serta kualitas hidup pasien.

Pelayanan ini mencakup pengkajian khusus geriatri, pencegahan risiko (seperti risiko jatuh, malnutrisi, dan penurunan fungsi), penatalaksanaan penyakit kronis, dukungan psikososial, serta keterlibatan keluarga dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan, sesuai dengan standar akreditasi dan prinsip keselamatan pasien.

2.2. RUANG LINGKUP

- A. Ruang rawat inap
- B. Instalasi Gawat Darurat
- C. Instalasi Rawat Jalan
- D. Instalasi Kamar Operasi

2.3. TATA LAKSANA

- A. Lakukan identifikasi pasien dalam hal usia dan penggolongan pasien usia lanjut.
- B. Lakukan identifikasi pasien usia lanjut yang datang ke UGD/ poliklinik , melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang sesuai indikasi , untuk dilakukan assesment awal.
- C. Rumuskan rencana asuhan pasien oleh Dokter termasuk kebutuhan penggunaan alat bantu sehari- hari untuk kenyamanan dan kemandirian pasien.
- D. Berikan penjelasan oleh dokter kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya alat bantu, cara penggunaan alat bantu serta resiko penggunaan alat bantu dalam jangka waktu lama , jika tidak disertai perawatan yang tidak benar.
- E. Berikan edukasi tentang asuhan pasien dengan penggunaan alat bantu agar tidak menimbulkan resiko yang tidak diinginkan misalnya dekubitus, atropi otot, dll.
- F. Lakukan konsultasi / alih rawat ke bagian disiplin ilmu lain jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan asuhan pasien.

BAB III

PELAYANAN TERHADAP POPULASI DISABILITAS

3.1. PENGERTIAN

Pelayanan terhadap pasien yang penyandang disabilitas baik disabilitas sejak lahir maupun disabilitas yang didapatkan karena kecelakaan maupun trauma fisik. Penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai keterbatasan mental, fisik, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu yang lama. Ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hambatan maka hal itu akan menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Rumah Sakit berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada pasien disabilitas baik dalam bentuk asuhan keperawatan maupun pelayanan aksesibilitas sarana dan prasarana. Sarana yang disiapkan untuk penyandang disabilitas adalah kamar mandi ramah penyandang disabilitas, ruangan yang mudah akses untuk meminta bantuan perawat, kemudahan akses sarana prasarana untuk menggunakan kursi roda.

A. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang.

B. Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.

C. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

D. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

E. Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.

3.2. RUANG LINGKUP

A. Ruang Rawat Inap

B. Instalasi Gawat Darurat

C. Instalasi Rawat Jalan

3.3. TATA LAKSANA

- A. Lakukan identifikasi pasien yang datang ke IGD/ poliklinik, melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang sesuai indikasi , untuk dilakukan assesmen awal.
- B. Jika didapatkan pasien penyandang disabilitas, rumuskan rencana asuhan pasien oleh Dokter termasuk kebutuhan penggunaan alat bantu sehari- hari untuk kenyamanan dan kemandirian pasien.
- C. Berikan penjelasan oleh dokter kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya alat bantu, cara penggunaan alat bantu serta resiko penggunaan alat bantu dalam jangka waktu lama , jika tidak disertai perawatan yang tidak benar.
- D. Berikan edukasi tentang asuhan pasien dengan penggunaan alat bantu agar tidak menimbulkan resiko yang tidak diinginkan misalnya dekubitus, jatuh, dll.
- E. Lakukan konsultasi/ alih rawat ke bagian disiplin ilmu lain jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan asuhan pasien.

BAB IV

PELAYANAN TERHADAP POPULASI ANAK

4.1. PENGERTIAN

Pemberian asuhan kepada pasien dengan kriteria anak yang membutuhkan bantuan orang lain/ petugas kesehatan karena kebutuhan ketergantungan, seperti:

- A. Pasien dengan batasan umur di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun
- B. Pasien anak dengan kondisi sakit sedang dan sakit berat.
- C. Pasien anak dengan kondisi terpasang alat.

4.2. TUJUAN

Memberikan asuhan kepada pasien dengan kriteria anak yang membutuhkan bantuan orang lain/ petugas kesehatan karena kebutuhan ketergantungan untuk prioritas keselamatan pasien.

4.3. RUANG LINGKUP

- A. Ruang Rawat Inap Anak
- B. Ruang Perinatologi
- C. ICU
- D. IKO
- E. IGD
- F. Instalasi Rawat Jalan

4.4. TATALAKSANA

- A. Tempatkan pasien nyaman mungkin.
- B. Informed consent dengan keluarga tentang pelaksanaan tindakan.
- C. Berikan penjelasan kepada pasien tentang tujuan tindakan.
- D. Lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik.
- E. Hal-hal yang perlu diperhatikan:
- F. Kondisi pasien.
- G. Hindari adanya trauma pada anak dan orang tua saat intervensi/ tindakan asuhan keperawatan maupun kedokteran.
- H. Turunkan dampak perpisahan antara orang tua dengan anak.
- I. Kriteria anak dengan ketergantungan, kelainan tumbuh kembang, cerebral palsy, Autisme, hyperactivity, down syndrom, kelainan berpikir (attention defisit hyperactivity disorder).

BAB V

PELAYANAN TERHADAP POPULASI YANG BERISIKO DISIKSA

5.1. PENGERTIAN

Pelayanan terhadap populasi yang berisiko disiksa seperti korban KDRT, pelaku kejahatan yang dirawat di Rumah Sakit, korban pemerkosaan, korban kekerasan lainnya, maupun populasi yang mendapat tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.

5.2. RUANG LINGKUP

- A. Ruang rawat inap
- B. Instalasi Gawat Darurat
- C. Instalasi Rawat Jalan
- D. IKO

5.3. TATALAKSANA

- A. Lakukan identifikasi dan asesmen awal pasien yang datang ke UGD/ poliklinik, melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang sesuai indikasi.
- B. Masalah medis segera dilaksanakan oleh PPA yang berkompeten dan berwenang.
- C. MPP mengkoordinasikan kebutuhan pasien terutama dengan pihak keamanan Rumah Sakit.
- D. Pihak keamanan Rumah Sakit harus mampu menilai tingkat risiko kebutuhan keamanan pasien, jika terdapat risiko tinggi penyiksaan terhadap pasien, pihak keamanan Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- E. Jika populasi yang berisiko bukan pasien melainkan keluarga pasien maupun orang yang sedang berada di lingkungan Rumah Sakit, pihak keamanan Rumah Sakit wajib melakukan pengamanan sampai berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

BAB VI

PELAYANAN TERHADAP POPULASI YANG BERISIKO BUNUH DIRI

6.1. PENGERTIAN

Bunuh diri merupakan salah satu bentuk kegawat daruratan psikiatri. Bunuh diri adalah perilaku yang membutuhkan pengkajian yang komprehensif pada depresi, penyalahgunaan NAPZA, skizofrenia, gangguan kepribadian (paranoid, borderline, antisocial), bunuh diri tidak bisa disamakan dengan penyakit mental.

Perilaku Bunuh diri Dibagi menjadi tiga kategori :

- A. Ancaman bunuh diri
Ada peringatan verbal dan non verbal, ancaman ini menunjukkan ambivalensi seseorang terhadap kematian. Jika tidak mendapat respon maka akan ditafsirkan sbg dukungan untuk melakukan tindakan bunuh diri.
- B. Upaya bunuh diri
Semua tindakan yang dilakukan individu terhadap diri sendiri yang dapat menyebabkan kematian jika tidak dicegah.
- C. Bunuh diri
Terjadi setelah tanda peringatan terlewatkan atau diabaikan. Perilaku bunuh diri menunjukkan terjadinya kegagalan mekanisme koping. Ancaman bunuh diri merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan pertolongan untuk mengatasi masalahnya.

6.2. RUANG LINGKUP

- A. Ruang rawat inap
- B. Instalasi Gawat Darurat
- C. Instalasi Rawat Jalan
- D. Instalasi Kamar Operasi

6.3. TATA LAKSANA

- A. Memeriksa pasien yang berusaha bunuh diri, jangan meninggalkan mereka sendirian dan keluarkan benda yang berbahaya dari ruangan.
- B. Pasien yang baru saja melakukan usaha bunuh diri, penatalaksanaannya adalah sangat tergantung pada diagnosis.
 - 1) Pada pasien dengan gangguan depresi berat mungkin diobati sebagai pasien rawat jalan jika keluarganya dapat mengawasi mereka secara ketat dan pengobatannya dapat dimulai secara cepat.
 - 2) Ide bunuh diri pada pasien alkoholik biasanya menghilang dengan abstinensi dalam beberapa hari. Jika depresi menetap setelah tanda psikologis dari putus alkohol yang menghilang dengan adanya kecurigaan yang tinggi pada gangguan depresi berat
 - 3) Ide bunuh diri pada pasien skizofrenia harus ditanggapi secara serius, karena mereka cenderung menggunakan kekerasan atau metode yang kacau dengan letalitas yang tinggi.
 - 4) Pasien dengan gangguan kepribadian mendapat manfaat dari konfrontasi empatik dan bantuan dengan mendapatkan pendekatan yang rasional dan bertanggung jawab.
- C. Hospitalisasi jangka panjang, diindikasikan pada keadaan yang menyebabkan mutilasi diri.
- D. Psikoterapi dengan pedoman wawancara.

-
- E. Mulailah dengan bertanya apakah pasien pernah merasa menyerah atau merasa mereka lebih baik meninggal. Pendekatan tersebut menyebabkan stigma yang kecil dan dapat dilakukan sebagian besar orang.
 - F. Berbicaralah mengenai apa yang sebenarnya yang difikirkan pasien dan catatlah pikirannya.
 - G. Pertimbangkan usia pasien dan apakah maksud pertanyaan pasien sesuai dengan caranya.
 - H. Apakah cara yang dipilih untuk bunuh diri tersedia pada pasien.
 - I. Pertanyaan yang terakhir menentukan penilaian dan pengobatan karena pasien dapat menunjukkan cara untuk keluar dari dilemanya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 Oktober 2025
PLT Direktur RS Prima Husada Malang

dr. Resti Lestantini, M.Kes